Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção B da 28ª Vara Cível da Capital

AV DESEMBARGADOR GUERRA BARRETO, S/N, FORUM RODOLFO AURELIANO, ILHA JOANA BEZERRA, RECIFE - PE - CEP: 50080-800 - F:( )

Processo nº **0139509-06.2023.8.17.2001**
AUTOR(A): C. A. N. D. M. F.
REPRESENTANTE: CLAUDIA ANGELO DO NASCIMENTO FREYRE
RÉU: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
SENTENÇA – Extinção com resolução do mérito
Vistos etc.

CAIO ÂNGELO NASCIMENTO DE MELLO FREYRE, representado por sua genitora, CLÁUDIA ÂNGELO DO NASCIMENTO FREYRE, propôs AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E LIMINAR CC DANOS MORAIS em face de SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.

Afirma o autor ser beneficiário de plano de saúde da Operadora demandada e ter sido diagnosticado com TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID10: F84.0) TDAH (CID F90.0), tendo lhe sido indicado tratamento com equipe multiprofissional e realização de terapias no método ABA.

Narra, ainda, que ao procurar a concessionaria de plano de saúde a mesma negou cobertura ao tratamento em clínica particular.

Inconformado com a situação, ajuizou a presente ação, requerendo, liminarmente, fosse a Requerida compelida a custear o tratamento objeto da lide, no mérito, a confirmação da medida liminar, e que a Requerida seja condenada a indenizar a parte Autora por danos morais em valor não inferior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Despacho inicial de citação e intimação da demandada para falar sobre o pedido de tutela (id. 150497247).

Regularmente citado, o Demandado apresentou manifestação quanto ao pedido de tutela de urgência no id. 152762081.

Posteriormente a Ré apresentou contestação e documentos nos ids. 154316597 a 154316601.

Réplica deduzida no id. 156349047.

Intimado a intervir no feito, o Ministério Público apresentou manifestação (id. 158687917).

É o que importa relatar. Passo à decisão.

Inicialmente, pontue-se que a demanda em tela comporta julgamento antecipado (julgamento conforme o estado do processo), posto que, embora envolva matéria fática, entendo que não há necessidade de produção de provas outras além das que já foram produzidas (art. 330, I, do Código de Processo Civil).

Sobreleva destacar que, na esteira do disposto pelo artigo 139, inciso II, do Código de Processo Civil, compete ao juiz velar pela rápida solução do litígio. Nesses casos, o julgamento do processo no estado em que se encontra é dever de ofício do juiz, e não mera liberalidade conferida por lei, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Ainda, a duração razoável do processo é imperativo advindo da Constituição, em seu artigo 5º, inciso LXXVIII.

Destarte, perfeitamente cabível que se julgue antecipadamente o mérito. Outrossim, verifico satisfeitas as exigências do artigo 10, do Código de Processo Civil, posto que as partes tiveram a oportunidade de debater as teses apresentadas nos autos.

Pois bem, trata-se de Ação De Obrigação De Fazer Com Pedido De Tutela Provisória, ajuizada por CAIO ÂNGELO NASCIMENTO DE MELLO FREYRE, representado por sua genitora, CLÁUDIA ÂNGELO DO NASCIMENTO FREYRE, todos qualificados nos autos, requerendo que seja compelida, a ré, a custear integralmente o tratamento do transtorno do espectro autista do autor, pelo método ABA, conforme prescrito pelo médico que o acompanha.

Consoante outrora asseverado, a demandada, devidamente citada para angularizar a relação processual, apresentou manifestação quanto ao pedido de tutela de urgência no id. 152762081.

Posteriormente a Ré apresentou contestação e documentos nos ids. 154316597 a 154316601. Em preliminares pugna pela impugnação da justiça gratuita; inépcia da petição inicial e ausência de interesse processual.

No mérito, em apertada síntese, alega que a negativa ocorreu dentro da legalidade, uma vez que o tratamento especificamente com as técnicas indicadas não se enquadra no rol de procedimentos da ANS de cobertura obrigatória; aduziu quanto ao caráter taxativo do Rol da ANS, da ausência de cobertura obrigatória de tratamento em ambiente escolar e domiciliar.

Ademais, afirmou sobre existência de rede apta ao atendimento; do reembolso nos limites contratuais; da necessária observância do mutualismo e preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato; da ausência de configuração dos danos morais.

DAS PRELIMINARES.

DA IMPUGNAÇÃO AOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDOS AO AUTOR

No que atine à impugnação à concessão das benesses da gratuidade judiciária ao demandante, desacolho-a, posto que este (que, para o gozo dos benefícios da gratuidade judiciária, pode ser representado por advogado particular), quando do ingresso em juízo, acostou ao caderno processual além da declaração de hipossuficiência, o contracheque da sua genitora (não refutada suficientemente pela parte contrária), comprovando a impossibilidade de suportar, sem prejuízo próprio, os ônus decorrentes do processo.

Nesse ínterim, é de se relevar, ainda, que a condição de necessitado não pode ser medida com instrumento de precisão, sendo de reconhecer que nem sempre a realidade patrimonial reflete a situação financeira do requerente, cedendo, em princípio, à afirmação do postulante de não possuir condição econômica para arcar com as despesas processuais.

DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL.

Nesse ponto a parte ré alega inépcia da inicial, sustentando que os pedidos formulados pela parte autora são de natureza genérica, futura e indeterminados.

Não merece acolhida.

A petição inicial contém todos os requisitos exigidos em lei, não havendo pedido genérico e tampouco indeterminado.

Ocorre que o laudo médico, com razão aduz que o tratamento deve ser prestado continuamente e por tempo indeterminado, haja vista ser uma condição especial que não se cura, mas trata-se afim de se amenizar os sintomas e permitir o convívio social.

Aliás o Transtorno do Espectro Autista – TEA – não é considerado uma doença, mas uma condição equiparada a deficiência, consoante Art. 1º, §2º da Lei 12.764 que instituiu a política Nacional de Proteção dos direitos da pessoa com Autismo.

Assim, não há como fixar prazo para o tratamento, uma vez que ele se perpetua com o tempo, e varia de acordo com a avaliação do paciente, pelo médico assistente.

Portanto, eventual mudança no tratamento e seu fornecimento guarda relação direta com o pedido formulado na petição inicial, qual seja: o fornecimento integral do tratamento do autor Autista conforme laudo médico, de maneira que a modificação nas terapias a serem fornecidas não extrapola a extensão material solicitada.

Posto isso, considero que a petição inicial aposta cumpre com todos os requisitos, e por isso refuto a presente preliminar.

DA AUSÊNCIA DE INTERESSE.

Em outro ponto, o plano de saúde afirma que a parte autora não possui interesse processual com relação ao pedido de custeio de sessões com cobertura prevista no rol de procedimento e eventos em saúde, sustentando que "não há necessidade de postular em juízo o direito a uma cobertura que já lhe é assistida".

Novamente sem razão.

O interesse processual encontra-se verificado, na negativa da demandada ao fornecimento do tratamento com profissionais especializados.

Assim, na medida que a parte Ré, intimada a falar sobre o pedido de tutela, não demonstra a disponibilidade do tratamento, mas ao contrário, resiste a ação, resta ratificado o interesse processual, havendo que ser rejeitada a preliminar avençada.

Enfrentadas as preliminares, passo à análise do mérito.

De início, é de se salientar que a demanda em tela subsume-se aos ditames da legislação consumerista, nos termos da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça através da Súmula 608, cujo teor assim se corporifica:

> Súmula 608: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão

Observo que o laudo médico de ID. 150320484, subscrito pela médica especialista (neurologia pediátrica) Dra. Sophie Helena Eickmann (CRM 8437), ilustra esclarecimentos sobre o quadro clinico da parte autora e a imprescindibilidade de tratamento prescrito, prescreve que que a criança, portadora de TEA – Transtorno do Espectro Autista, CID 10:F84.0, precisa ser acompanhada por equipe multiprofissional para realizar terapias específicas, baseadas na ciência do comportamento ABA.

O programa prescrito pelo médico assistente consiste, além do acompanhamento regular com médico pediatra e neuropediatra, nas seguintes terapias: i) Psicoterapeuta certificada no método ABA (cinco sessões semanais por 2h cada), com mestrado ou doutorado em Análise Aplicada do Comportamento (ABA), apto a criar e supervisionar o programa específico do paciente; ii) Fonoaudiologia (duas sessões semanais); iii) Terapia Ocupacional (duas sessões semanais); iv) Psicopedagogia (duas sessões semanais).

Ressalta que as terapias devem ser realizadas por profissionais qualificados e capacitados no atendimento de pacientes com Transtorno do Espectro do Autismo e que tais abordagens devem ser **por tempo indeterminado** e que a falha em seguir essa prescrição é danosa ao prognóstico e, consequentemente, à qualidade de vida da criança e da família.

De outra banda, o tratamento direcionado às necessidades do Autor é contestado pela operadora, sob os seguintes fundamentos: a) os procedimentos em tela não estariam inseridos no rol de cobertura mínima obrigatória da ANS, sobretudo com a técnicas indicada; b) a falta de previsão contratual e legal para a realização de sessões em casa e na escola.

Malgrado o reconhecimento da taxatividade do rol da ANS (conforme decidido pela 4.ª Turma do STJ, no REsp. 1733013 e, posteriormente, em 08 de junho de 2022, pela 2.ª Seção do STJ, nos EREsp 1.886.929 e o EREsp 1.889.704), a edição da Resolução Normativa nº 539, de 23 de junho de 2022, que deu nova redação ao § 4º do art. 6º da RN nº 465, de 24 de fevereiro de 2021, da ANS, assim definiu as modalidades dos tratamentos prescritos para portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista:

> "Art. 6º [...]
>
> § 4º Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente."

Esta Resolução, que passou a ter vigência em 1º de julho de 2022, tornou inequívoco que o plano deve cobrir todo e qualquer método indicado pelo médico para tratamento de autismo e seu espectro terapêutico requerido.

Igualmente superada a questão do limite de sessões a serem cobertas pelo plano; pouco tempo depois da Resolução acima, a ANS publicou a Resolução nº 541, de 11 de julho de 2022, que retirou os limites de sessões de cobertura para atendimento com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, revogando as diretrizes de utilização antes estabelecidas.

Tais resoluções, combinadas, conferem amplo e irrestrito acesso em espécies de tratamento e em quantidade de sessões às terapias disponíveis para os portadores de autismo e transtornos do espectro autista.

Com isso, qualquer discussão acerca da própria taxatividade do Rol da ANS resta esvaziada, porquanto o tratamento está inequivocamente inserido dentro da cobertura mínima a ser oferecida pelos planos.

No mesmo sentido, a Seção Cível do TJPE, no julgamento do IAC de autos n.° 0018952-81.2019.8.17.9000, ocorrido em 26 de julho de 2022, fixou as seguintes teses, vinculantes no âmbito da Justiça Estadual:

> "Diante do tudo que foi explicitado, e, considerando a relevância social do tema, conforme é sabido por todos, e tão esperado pela sociedade brasileira, o meu voto é no sentido de acolher o IAC – Incidente de Assunção de Competência, em conformidade com as normas previstas no CPC e Regimento Interno da Corte, fixando as seguintes teses:
>
> Tese 1.0 – Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários com o Transtorno do Espectro Autista, a operadora deverá oferecer atendimento por

prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico ou dentista assistente para tratar a doença ou agravo do paciente, nos termos da Resolução Normativa da ANS nº 465/2021, (com a redação dada pela Resolução da ANS nº 539/2022), inclusive em ambiente escolar e domiciliar, à luz do disposto na Lei nº 12.764/2012 art. 3º, I, III e parágrafo único.

Tese 1.1 – Os requisitos necessários para que o profissional de saúde seja considerado especialista nos métodos ABA (análise do comportamento aplicada), BOBATH, HANEN, PECS, PROMPT, TEACCH e INTEGRAÇAO SENSORIAL, de acordo com o art. 6º da Resolução Normativa da ANS nº 465/2021, deve estar conforme legislação específica sobre as profissões de saúde e regulamentação de seus respectivos conselhos profissionais.

Tese 1.2 – Comprovada a inaptidão e/ou indisponibilidade da rede credenciada para oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente com TEA – Transtorno do Espectro Autista, cabe o custeio pelo plano de saúde do mesmo tratamento na rede particular, consoante dispõe a Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS.

Tese 1.3 – O reembolso: a) será nos termos do contrato, consoante previsto no art. 12, VI, da Lei 9.656/1998, para os casos em que, mesmo havendo a prestação adequada do serviço de saúde na rede credenciada, o beneficiário optar por realizá-lo na rede particular; **b) será integral, no prazo de 30 (trinta) dias, quando a operadora descumpre o seu dever de garantir o atendimento, ante a indisponibilidade ou inexistência de prestador integrante da rede assistencial conveniada, nos termos do art. 9º da Resolução da ANS nº 259/2011;** c) será integral, no prazo de 30 (trinta) dias, na hipótese em que, por recusa manifestamente indevida de cobertura pelo plano de saúde, o beneficiário seja obrigado a pagar os custos do atendimento. Tese
1.4. - A negativa de custeio das terapias multidisciplinares de cobertura contratual obrigatória para tratamento do Transtorno do Espectro Autista poderá ensejar reparação por danos morais, mesmo antes da entrada em vigor da Resolução Normativa da ANS nº 539/2022.

Tese 2.0 - As terapias especiais de hidroterapia, equoterapia, musicoterapia, psicopedagogia e psicomotricidade, quando aplicadas por profissionais da área de saúde, têm obrigatoriedade de cobertura pelas operadoras de planos de saúde.

Tese 2.1 - Comprovada a inaptidão e/ou indisponibilidade da rede credenciada para oferecer atendimento por prestador apto a executar as terapias especiais de hidroterapia, equoterapia, musicoterapia, psicopedagogia e psicomotricidade, indicadas pelo médico assistente para

tratar doença ou agravo do paciente com TEA – Transtorno do Espectro Autista, cabe o custeio pelo plano de saúde do mesmo tratamento na rede particular, consoante dispõe a Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS.

Tese 2.2 – O reembolso para as terapias especiais de cobertura obrigatória de hidroterapia, equoterapia, musicoterapia, psicopedagogia e psicomotricidade: a) será nos termos do contrato, consoante previsto no art. 12, VI, da Lei 9.656/1998, para os casos em que, mesmo havendo a prestação adequada da terapia na rede credenciada, o beneficiário optar por realizá-la na rede particular; b) será integral, no prazo de 30 (trinta) dias, quando a operadora descumpre o seu dever de garantir o atendimento, ante a indisponibilidade ou inexistência de prestador integrante da rede assistencial conveniada, nos termos do art. 9º da Resolução da ANS nº 259/2011; c) será integral, no prazo de 30 (trinta) dias, por recusa manifestamente indevida de cobertura pelo plano de saúde, o beneficiário seja obrigado a pagar os custos do atendimento.

Tese 2.3. - A negativa de custeio das terapias especiais de hidroterapia, equoterapia, musicoterapia, psicopedagogia e psicomotricidade de cobertura contratual obrigatória para tratamento do Transtorno do Espectro Autista enseja reparação por danos morais, a partir da entrada em vigor da Resolução Normativa da ANS nº 539/2022, que as regulamentou."

(IAC n.° 0018952- 81.2019.8.17.9000, Seção Cível do TJPE, Relator Des. Tenório dos Santos, data do julgamento 26-07-2022).

Essas novidades regulatórias são enfáticas quanto à obrigatoriedade de cobertura da terapia multidisciplinar sendo, portanto, abusiva a recusa do plano.

Assim, inconteste o direito do Autor de ter prestados **todos** os tratamentos indicados por seu médico assistente, que é o responsável pela prescrição do tratamento do menor, não cabendo à seguradora questionar quanto ao tratamento indicado.

Afere-se que, em verdade, o seguro de saúde oportuniza ao usuário utilizar-se dos profissionais em estabelecimentos credenciados ao plano, ou, alternativamente, escolher os profissionais de sua preferência, caso em que terá a despesa ressarcida nos limites definidos pela seguradora.

De mais a mais, é de se ter em conta que, na seara da relação consumerista é possível a inversão do ônus da prova a favor do consumidor, a teor do disposto no Art. 6º, VIII do CDC, cabendo à recorrente comprovar a aptidão da rede credenciada para a realização do tratamento, não se mostrando satisfatória a tanto, a mera alegação da existência de clínicas e/ou profissionais nas diversas áreas de assistência à saúde, uma vez que o tratamento para o autismo requer procedimentos terapêuticos específicos e individualizados.

Ademais, observo que a parte Demandada menciona ter clínicas aptas a prestar o tratamento, mas não junta nenhum documento a comprovar a qualificação e especialização dos profissionais credenciados, sobretudo quanto a técnica a ser empregada ABA.

Assim deve incidir, na espécie, o disposto no art. 4º da RN nº 59, da ANS, que assegura ao paciente o custeio do tratamento fora da rede credenciada oferecida pela operadora de serviços de assistência à saúde na hipótese de ausência ou inexistência de prestador credenciado, que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto.

Ademais, consoante transcrito acima, no julgamento do IAC, dentre as teses firmadas pelo Tribunal, temos como destaque no caso a tese 1.3, a qual aduz que:

> Tese 1.3 – O reembolso: a) será nos termos do contrato, consoante previsto no art. 12, VI, da Lei 9.656/1998, para os casos em que, mesmo havendo a prestação adequada do serviço de saúde na rede credenciada, o beneficiário optar por realizá-lo na rede particular; **b) será integral, no prazo de 30 (trinta) dias, quando a operadora descumpre o seu dever de garantir o atendimento, ante a indisponibilidade ou inexistência de prestador integrante da rede assistencial conveniada, nos termos do art. 9º da Resolução da ANS nº 259/2011;** c) será integral, no prazo de 30 (trinta) dias, na hipótese em que, por recusa manifestamente indevida de cobertura pelo plano de saúde, o beneficiário seja obrigado a pagar os custos do atendimento. Tese
> 1.4. - A negativa de custeio das terapias multidisciplinares de cobertura contratual obrigatória para tratamento do Transtorno do Espectro Autista poderá ensejar reparação por danos morais, mesmo antes da entrada em vigor da Resolução Normativa da ANS nº 539/2022.

Assim, desnecessária a análise do contrato firmado quanto ao reembolso, uma vez que o importante é concluir se há disponibilidade do tratamento na rede credenciada, porquanto não havendo opção, o reembolso será INTEGRAL, independente do que estiver previsto no contrato.

Sendo assim, como dito, resta evidente que, em se tratando de reembolso não prevalecerá, no caso, em relação ao valor do Coeficiente de Reembolso de Seguro, ou seja, em relação ao valor estabelecido em sua tabela de ressarcimento por sessão/profissional, já que não foi opção do autor realizar o tratamento com o profissional que melhor lhe conviesse em preterição àqueles disponibilizados pelo seguro de saúde em rede conveniada.

Ao revés disso, não obteve do plano de saúde demandado a disponibilização do tratamento.

Destarte, resta inafastável o reconhecimento à indisponibilidade do direito fundamental à saúde e à vida, elevados pela Constituição Federal à condição de direito fundamental do homem, manifestando o legislador constituinte constante

preocupação em garantir a todos uma existência digna.

No que tange aos danos morais, igual sorte detém o Requerente, verificada a ilegalidade na conduta do demandado que deveria ter viabilizado o tratamento da parte autora, nos termos prescritos pelo médico que o acompanha, conforme já exposto e, sendo inquestionável o nexo causal, destaco que a recusa indevida da assistência, o que se deu no momento em que o paciente mais necessitava, representa afronta aos seus direitos de personalidade, pois, embora tenha contratado um seguro de saúde justamente para evitar quaisquer complicações no momento em que eventualmente se deparasse com uma situação delicada, viu-se impedido, injustificadamente, de usufruir de direitos previstos decorrentes do próprio contrato, para o qual contribuiu.

Trata-se de situação excepcional, que por certo ultrapassa o mero descumprimento contratual, implicando injustificada ofensa à integridade física e psíquica, impondo desnecessário e significativo sofrimento à parte demandante que não teve acesso ao tratamento indispensável.

Dessa feita, configurado o direito à compensação pelos danos morais, tem-se que, relativamente à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, atentando-se para a extensão do dano, comportamento dos envolvidos, condições econômicas e sociais das partes e repercussão do fato, além da proporcionalidade e da razoabilidade.

Na fixação do valor devido a título de indenização por danos morais, prevalecerá o prudente arbítrio do julgador, evitando-se que a condenação se traduza em captação de vantagem indevida, ou que seja fixada em valor irrisório.

Por derradeiro, faz-se mister, nesta oportunidade, a concessão da Tutela de Urgência (que, ressalve-se, não encontra vedação, posto que a abundância das provas permite), já que mais do que demonstrado o direito do Requerente.

Diante do exposto e por tudo o mais que dos autos consta, e em consonância com os fundamentos explicitados, ***deferindo, nesta oportunidade, a Tutela de Urgência pleiteada,*** com supedâneo no art. 487, I, do Código de Processo Civil, **RESOLVO O MÉRITO, JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO EXORDIAL**, de modo a:

- DETERMINAR que a Demandada, custeie de IMEDIATO o tratamento prescrito no laudo médico atualizado no id. 155990504, sem qualquer restrição, que deverá ser realizado por profissionais credenciados, conveniados ou da rede própria da Ré e que sejam especialistas nas técnicas prescritas, sem qualquer tipo de limitação em relação aos parâmetros descritos no laudo ou valor de ressarcimento, sob pena de multa diária de R$ 1000,00 (hum mil reais) limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais);

Alternativamente, sob a mesma condição quanto à integralidade do tratamento e ausência de limite de número de sessões necessárias para o tratamento, **FACULTO À PARTE AUTORA** optar por manter os tratamentos indicados com os profissionais por ela eleitos mediante o sistema de reembolso, caso em que prevalecerá os limites remuneratórios das condições gerais do seguro.

Assevero que só incidirão os limites remuneratórios das condições gerais do seguro, se o seguro saúde demando viabilizar todo o aparato para o tratamento do autor NOS EXATOS TERMOS DO LAUDO MÉDICO DE ID 155990504, e, ainda assim, a parte autora prefira fazer o tratamento com profissionais diversos.

Registre-se que a intimação da parte requerida para que cumprimento da obrigação deve se dar PESSOALMENTE, através de carta com aviso de recebimento.

- CONDENAR o Demandado, consoante textualizado nos fundamentos desta decisão, a pagar ao demandante, à título de compensação por danos morais, o valor de R$ 10.000,00 (*dez mil reais*), a ser corrigido com base na tabela do ENCOGE, tendo-se por termo *a quo* a data da presente decisão (*Súmulas 362/STJ e 160 TJPE*); cominando-se, ainda, juros de mora no percentual de 1% (*art. 406 do CC em vigor e a sua combinação com o art. 161, §1º, do CTN*), tendo-se por termo inicial da sua incidência a data do evento danoso – *negativa do plano em custear o tratamento prescrito* – (*Súmula 155 TJPE*);

- CONDENO o demandado no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

No caso de interposição de recurso de apelação, intime-se a parte apelada, por intermédio de seus advogados/procuradores para, no prazo de 15 (quinze) dias (a teor do art. 1.010, §1º, do Código de Processo Civil), apresentar, querendo, contrarrazões.

Decorrido o prazo, com ou sem a apresentação da resposta, remetam-se os autos à instância superior, com as nossas homenagens, e após as baixas necessárias na Distribuição, independentemente de novo comando judicial.

Após cumpridas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE, com as baixas necessárias e as cautelas de estilo.

Recife-PE, data e assinatura eletrônicas.

MARCO AURÉLIO MENDONÇA DE ARAÚJO – Juiz de Direito

Assinado eletronicamente por: MARCO AURELIO MENDONCA DE ARAUJO
22/02/2024 12:05:01
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 161872134

24022212050111700000158115439

IMPRIMIR GERAR PDF